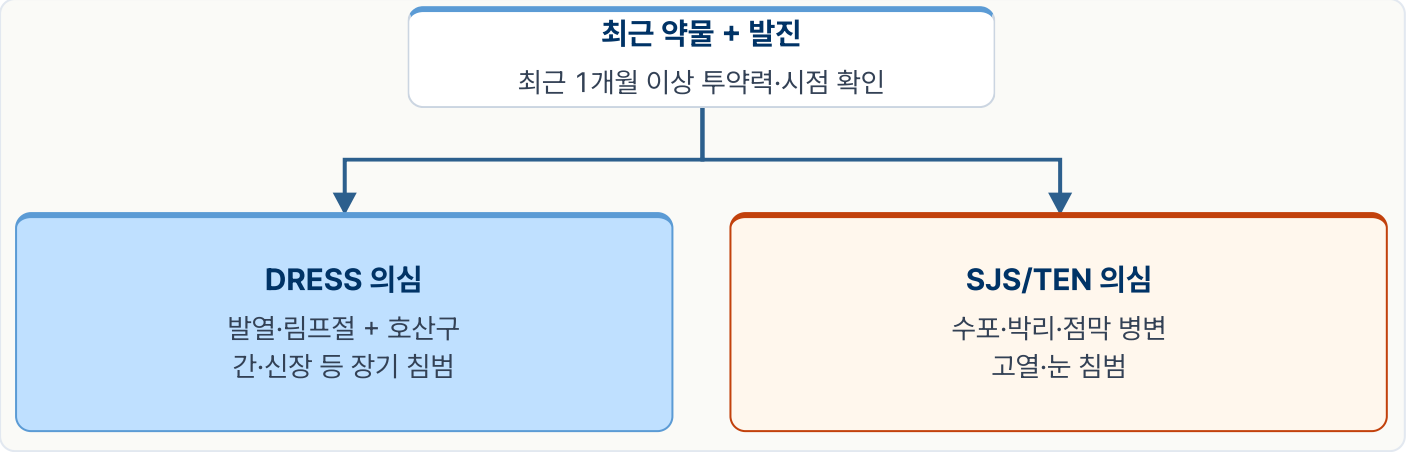
의료진 진료 카드 · ASL-079

중증 약발진 · 의심 즉시 연결

최근 약물과 피부·점막·전신 소견을 함께 본다. 점수를 모두 채우기 전에 원인 의심약 중단과 신속한 의뢰.

지연성 발진에 전신·점막 침범이 있으면



초기 인지 · 본강의

DRESS	발열·지연형 발진·림프절 비대(80~90%)와 내부 장기 침범. CBC의 호산구·백혈구·비정형 림프구, 간염·신염·간질성 폐렴 등을 본다.
시점·위험	DRESS 슬라이드: 약물 노출 후 2주~2개월, 1/1,000~1/10,000 노출, 사망률 약 10%(주로 간부전). 며칠~1~2주 이상 약력에서도 해당 소견이 함께 보이면 의심하라는 구두 강조.
SJS/TEN	자반성 반점·비전형 표적병변 위 작은 물집, 피부 박리, 입술·혀·생식기 등 점막 침범, 발열·권태. SJS에서 눈 침범 >60%로 소개.
즉시 연결	연자는 SJS 의심 시 원인약을 빨리 중단하고 상급병원으로 빨리 전원할 것을 강조. 다른 감염·괴질로 생각하며 시간을 끌지 않도록 설명.

감별할 피부 형태

흔한 반구진 발진	색 변화(macule)+융기(papule), 지연형의 흔한 형태. 원인약 중단을 기본으로 설명했지만 장기 침범·수포·점막 이상이 동반되면 중증 반응 경로로 본다.
고정약진·AGEP	같은 약마다 같은 위치·형태 재발과 색소침착은 고정약진. AGEP는 넓은 홍반 위 작은 무균성 농포·고열·호중구 증가; 교재 1~5일 발생, 중단 후 약 2주 탈락·호전으로 소개.

SJS/TEN의 피부 박리 면적은 분류의 한 축이다. 실제 초기 의뢰는 발진·수포·점막·눈 증상과 약물 시간 관계를 함께 보고 결정하며, 숫자만 채우느라 의뢰를 늦추지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-079

DRESS·SJS/TEN · 평가 도구

강의에 소개된 점수의 항목과 분류. 입원·전문 평가에서 원인약과 장기 침범을 정리하는 자료.

DRESS · 강의의 RegiSCAR 항목

발열·림프절	38.5°C 이상 발열(없음/모름 −1), 림프절 ≥2부위(+1).
혈액·피부	호산구 증가 +1~+2, 비정형 림프구 +1. 피부 >50%·DRESS형 소견·생검 항목, 생검 비전형 −1로 제시.
장기·경과	장기 1개/+1, ≥2개/+2. 경과 ≥15일과 다른 원인 배제 항목을 함께 평가.
합계·활용	<2 배제, 2~3 가능, 4~5 유력, >5 확실로 소개. 초기엔 의심·중단을 먼저 하고 입원 후 점수로 확인하는 설명.

SJS/TEN · ALDEN 약물 인과성

시간 관계	투약→발진 5~28일이 가장 의심되는 잠복기. 구두 설명은 심한 경우 약 2개월까지 약력을 본다고 언급.
평가 축	발진 시 약물 잔존, 같은 약 과거 반응·재투여력, 중단 후 경과, 알려진 SJS/TEN 원인약인지, 감염 등 다른 원인.
범위	−12~+10점, 합계 ≥6이면 원인약 가능성이 매우 높음으로 소개. SJS/TEN용 인과성 도구이며 초기 중단·의뢰를 대신하지 않는다.

피부 박리 분류 · 교재

EM·SJS

EM은 박리 0%, 전형적 3층 표적병변. SJS는 <10% 박리(비교표 1~10%), 비전형 2층 병변·자반.

Overlap·TEN

SJS/TEN overlap 10~30%; TEN >30%. TEN은 폭발적 광범위 수포·괴사·박리, 여러 점막 궤양·고열, 표적병변이 없을 수 있음.

위험 수치의 맥락

교재의 질환별 비교표 사망률: SJS 1~5%, SJS/TEN overlap 5~25%, TEN 25~35%.

의료진 진료 카드 · ASL-079

상급병원 치료 · 강의 상세

아래는 강의에 소개된 전문 치료 내용이다. 외래의 즉시 의뢰 경로와 분리해 읽는다.

SJS · 본강의 치료 소개

핵심	SJS 치료 슬라이드의 사망률 5~25%. 원인약 즉시 중단. 화상에 준한 집중치료: 수액·체온 유지·2차감염 감시. 수포 지붕 보존, silver sulfadiazine은 sulfa 교차를 이유로 금기로 소개.
전신 스테로이드	강의 제시: prednisone 1~2 mg/kg/일 3~5일; IV dexamethasone 1.5 mg/kg/일~100 mg/일; IV methylprednisolone 0.5~1 mg/kg/일 3일. 연자는 초기 짧은 고용량 사용을 설명하고 늦거나 길면 감염 위험을 강조.
다른 치료	Cyclosporine A 5 mg/kg/일, IVIG(용량·프로토콜 이질성), TNF-α 차단제 etanercept·adalimumab을 소개. 연자는 상급병원에서 시행하며 IVIG 논란·TNF 차단제 비급여 사용을 설명.
협진	안과·피부과·이비인후과 협진. 안과의 조기 개입·양막 치료와 2~3주 시간창을 강의에서 소개했으나, 외래는 의심 즉시 전원해 조기 평가로 연결.

TEN · 감염 위험과 사후 평가

TEN 단계	TEN 치료 슬라이드의 사망률 30~50%(주로 패혈증). 광범위 박리 후 감염·패혈증 위험을 강조하며, 연자는 이 단계에서 전신 스테로이드가 경우에 따라 금기가 된다고 설명.
재노출 예방	원인약 과거력·투여와 반응 시점 기록, 전문가 원인 평가, 약물 과민반응 카드로 처방 시 주의 공유.
지연형 검사	Patch test는 24~72시간 부착, 지연형 반응을 표적으로 하나 표준화가 부족. 검사 자체도 재반응 위험이 있어 꼭 필요한 경우 제한적으로 시행한다는 설명.

강의의 SJS 조기 스테로이드 설명과 TEN의 감염 위험 설명은 질환·단계별 맥락이 다르다. 이를 한 줄의 공통 처방으로 합치지 않고, 원인약 중단과 상급병원 전문 치료 연결을 우선한다.